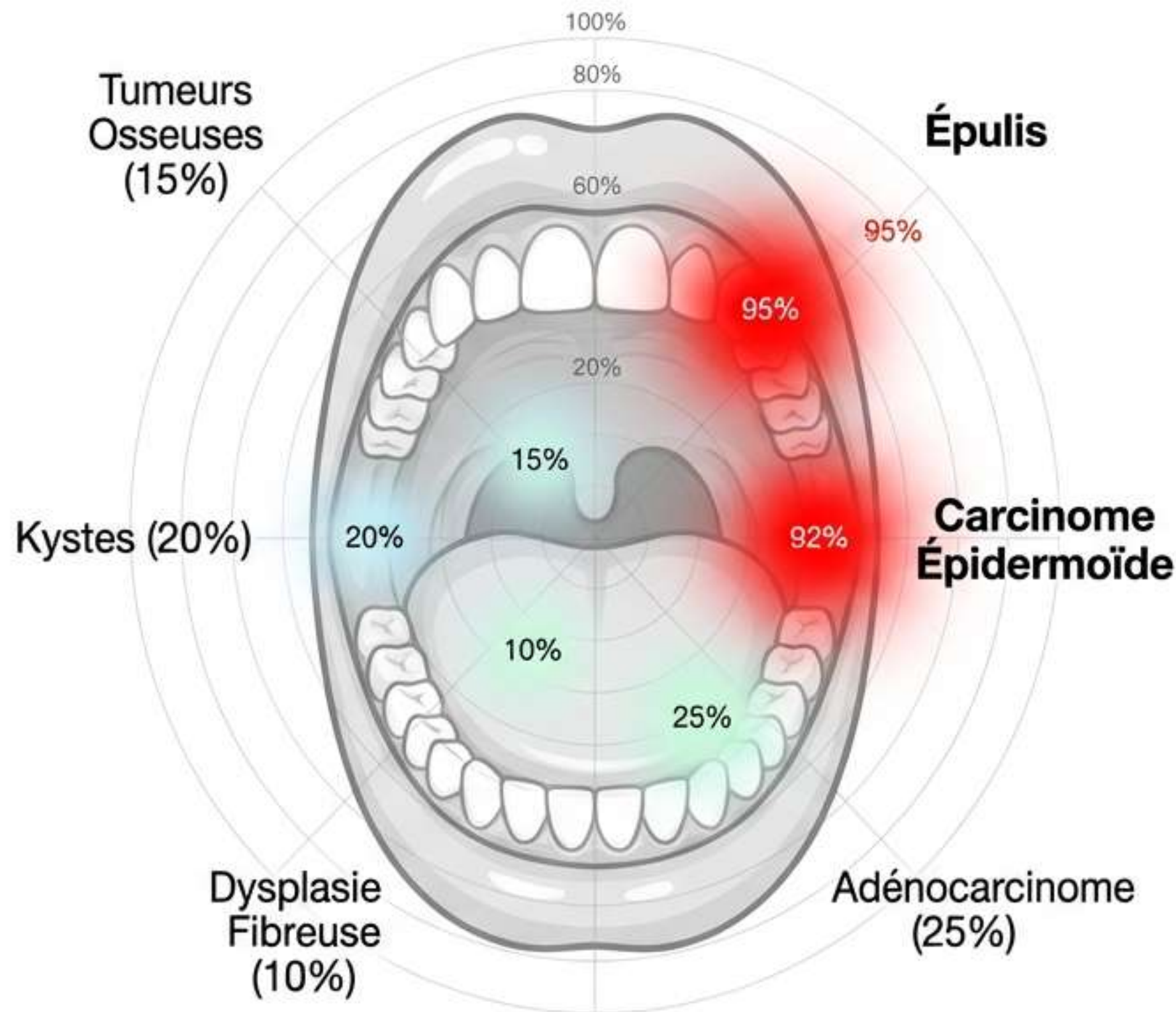


Analyse des Modèles d'Examen (Stratégie de Révision)



Sujets à Haute Fréquence

Epulis: Définition (tumeur bénigne), signes cliniques (saignement), et traitement (exérèse) sont les questions les plus récurrentes. [Ref: Q; Q2, Q5, Q14, Q19]

Carcinome Épidermoïde: Identifié systématiquement comme la tumeur maligne la plus fréquente de la cavité buccale. [Ref: Q3, Q4, Q8]

Pièges Classiques

Distinction entre "Tumeur Vraie" et "Pseudotumeur" (ex: Kystes, Dysplasie fibreuse). [Ref: Q15, Q16, Q20, Q22]

Histologie spécifique du palais mou (Carcinome épidermoïde vs Adénocarcinome). [Ref: Q4, Q18, Q21]

Prédictions IA

Attention aux classifications d'âge pour les tumeurs osseuses (Ostéosarcome 10-20 ans vs Chondrosarcome >40 ans).

Mémorisation stricte des translocations (Sarcome d'Ewing).

Pathologies Inflammatoires (1/3) : Les Aphtes



Définition & Clinique

Lésions bénignes, motif fréquent de consultation.

Ulcérations douloureuses de la muqueuse buccale, superficielles. [Ref : Q9]

Fond nécrotique (jaune/gris) avec halo rouge. Perçus comme des brûlures.

Facteurs Favorisants

- Stress.
- Aliments : Noix, gruyère, épices, kiwis. [Predicted – Reason: Specific list]
- Médicaments : Aspirine, antibiotiques.
- Traumatismes : Prothèse, morsure, brosse à dents.

Histologie & Évolution

Muqueuse inflammatoire ulcérée avec exsudat fibrinoleucocytaire.

Cicatrisation en 10 à 15 jours sans traitement.

Pathologies Inflammatoires (2/3) : Candidoses & Lichen

Les Candidoses ("Muguet")



- **Cause** : Colonisation massive par *Candida Albicans*.
- **Facteurs de risque** : Diabète, antibiothérapie prolongée, sécheresse buccale, dénutrition, immunosuppression. [Predicted – Reason: Systemic risk factors]
- **Aspect** : Plaques blanches OU rouge vif et lisse.
- **Symptômes** : Perte d'appétit, gêne, douleurs, saignements.
- **Histologie** : Granulome inflammatoire avec dépôts mycéliens.

Lichen Plan & Lésions Blanches



- **Grande variété** : lésions bénignes à cancéreuses.
- Toute modification muqueuse nécessite consultation.
- Le Lichen est une **lésion potentiellement à risque (pré-cancéreux)**. [Ref: Q7]

Pathologies Inflammatoires (3/3) : Épulis & Herpès



Aspect d'une épulis



Herpès labial

Les Épulis

- **Excroissances bénignes** de la gencive. [Ref: Q2, Q14]
- **Saignent** facilement. [Ref: Q14]
- **Traitement** : Exérèse chirurgicale. [Ref: Q14, Q19]
- **Variantes histologiques** : Angiomateuses, fibreuses, à cellules géantes ($\pm$ métaplasie osseuse). [Predicted – Reason: Subtypes]

Les Herpès

- **Diagnostic clinique** ('boutons de fièvre').
- **Vésicules** douloureuses groupées, liquide limpide très infectieux.
- **Rupture** puis **dessèchement**.

Tumeurs des Tissus Mous : Bénignes vs Malignes

Tumeurs Bénignes		Tumeurs Malignes (Carcinome Épidermoïde)	
Fibrome : 	• Croissance lente (mois/années), indolore. • Histologie : Prolifération fibroblastique + dépôts de collagène.	 Carcinome	Carcinome Épidermoïde : • Fréquence : Carcinome épidermoïde ++++ (Le plus fréquent). [Ref: Q3, Q4, Q8, Q12, Q21] • Caractéristiques : Mal circonscrits, développement très rapide. • Évolution : Infiltrant et détruisent les tissus, métastases. [Ref: Q10] • Formes : Bourgeonnantes, ulcérées, ulcéro-bourgeonnantes. • Histologie : Différenciation variable (mature ou non).
Hémangiome : 	• Nodule de cavités remplies de sang. • Prolifération vasculaire.		

Tumeurs Osseuses Non Dentaires : Tumeurs Bénignes

TUMEURS OSSEUSES D'ORIGINE NON ODONTOEGENE

Principe : Classification basée sur le tissu reproduit.

1. Ostéogéniques : Ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéome (fréquent cranio-facial).

2. Cartilagineuses : Chondrome, ostéochondrome, chondroblastome, fibrome chondromyxoïde.

3. Conjonctives : Fibromes, Dysplasie fibreuse (fréquent cranio-facial).

4. Cellules Géantes : Tumeurs à myéloplaxes, granulome central réparateur.

5. Chérubisme : Localisation angulo-mandibulaire, parfois maxillaire. [Predicted – Reason: Localization]

6. Vasculaires/Nerveuses : Angiomes, lipomes intraosseux, kystes anévrismaux.

Tumeurs Osseuses Malignes (1) : Ostéosarcome

Définition : Tumeur primitive de l'os, cellules élaborent du tissu osseux ostéoïde.

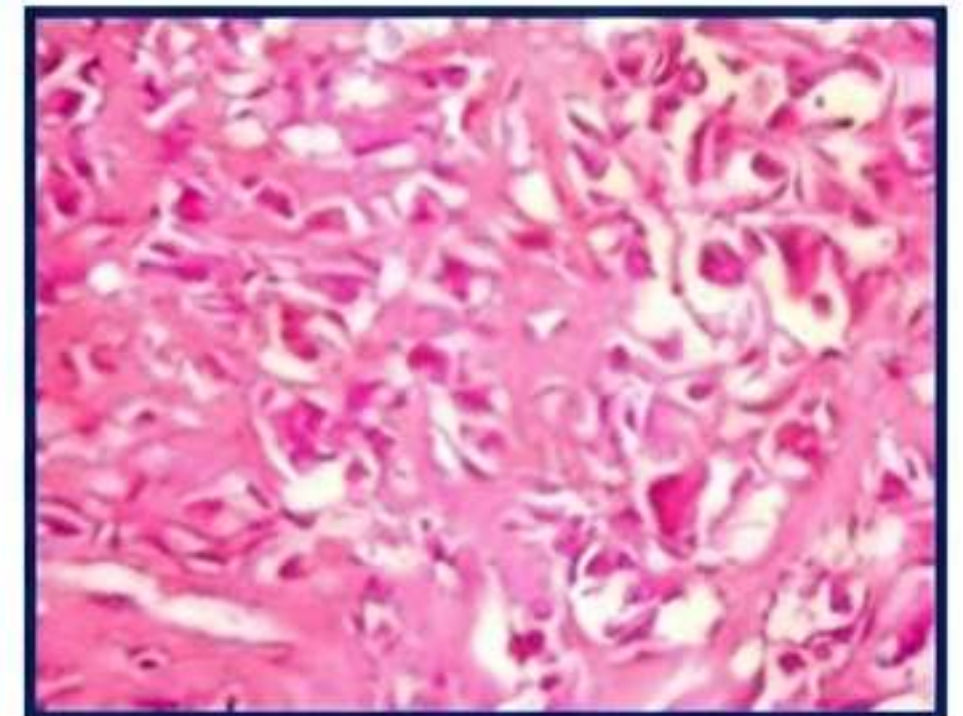
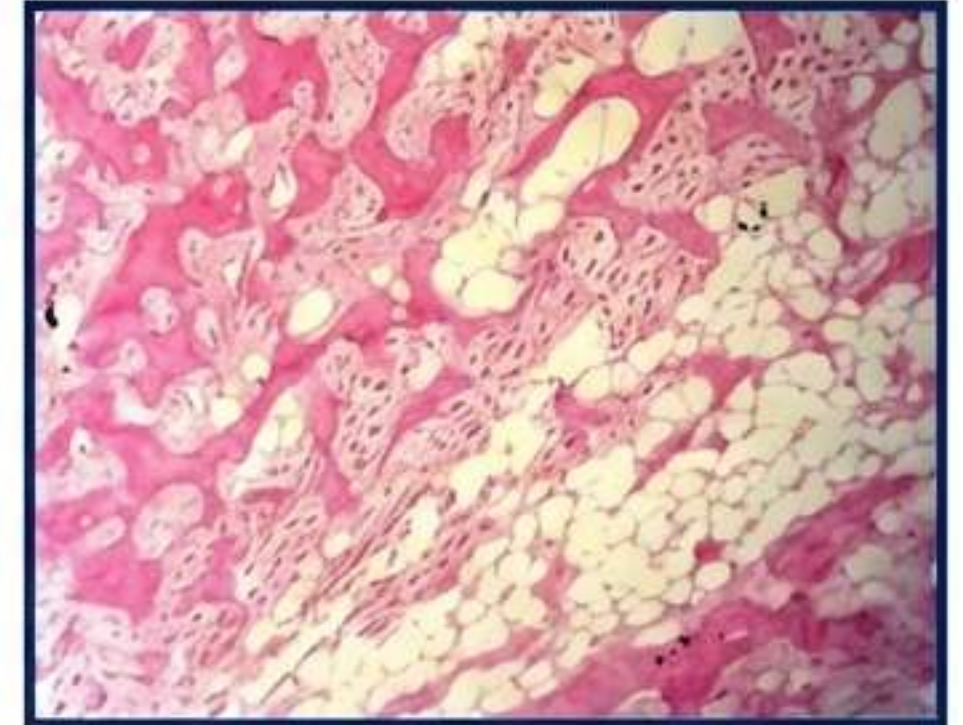
Épidémiologie : Plus de 50% des cas entre 10 et 20 ans.
[Predicted – Reason: Age value]

Clinique : Douleur + Tuméfaction (Symptômes d'alarme).

Radiologie (Signes de malignité) :

- Remaniement osseux diffus sans limites nettes.
- Plages d'ostéolyse ou de condensation.
- Rupture corticale, éperon périosté.
- Image d'ostéogénèse anarchique en « feu d'herbe ». [Ref: Classic Sign]

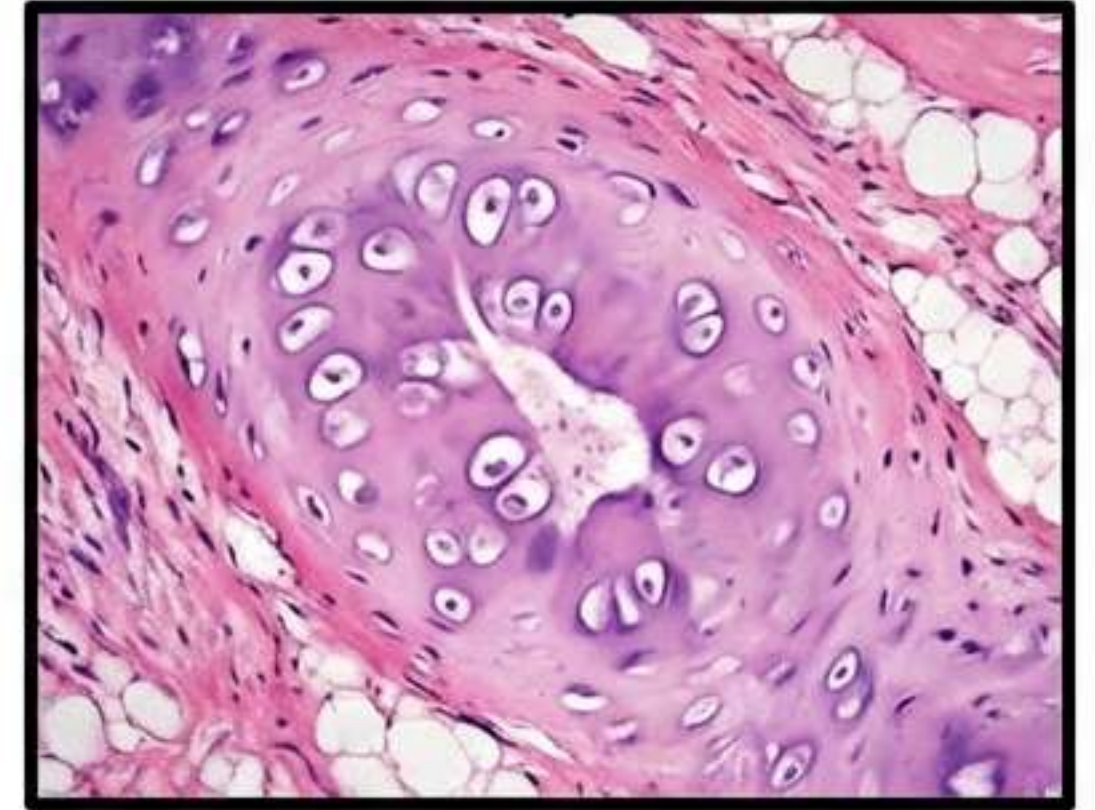
Traitement : Chimiothérapie → Chirurgie → Chimiothérapie.



Tumeurs Osseuses Malignes (2) : Chondrosarcome & Fibrosarcome

Chondrosarcome

- Production de cartilage tumoral (jamais d'os).
- **Âge** : Surtout après 40 ans. [Predicted – Reason: Contrast with Osteosarcoma]
- **Radiologie** : Lacune centrale polylobée/irrégulière, corticale grignotée.
- Localisations maxillaires peu fréquentes.



Fibrosarcome

- Différenciation fibroblastique pure (pas de tissu ostéo-cartilagineux).
- Radiologie : Lytique (ostéolyse ou lacune géodique).
- Prise en charge identique à l'ostéosarcome.

Tumeurs Osseuses Malignes (3) : Ewing, Lymphomes & Métastases

Sarcome d'Ewing

- Enfant et adolescent. Origine neuroectodermique.
- Marqueur : Translocation 11-22 ou 21-22. [Predicted – Reason: Genetic Marker]
- Biopsie au trocart et ponction médullaire multiple.

Lymphomes & Myélomes

- **Burkitt** : Grandes zones d'ostéolyse, rupture corticale, spicules osseux perpendiculaires.
- **Myélomes (Kahler)** : Lésions ostéolytiques multiples sans liseré de condensation.

Métastases

- Mandibule > Maxillaire.
- Lésions lytiques mal limitées ou ostéocondensantes (Prostate, Sein, Poumon).

Tumeurs Odontogènes : Définition & Histogenèse

Définition :

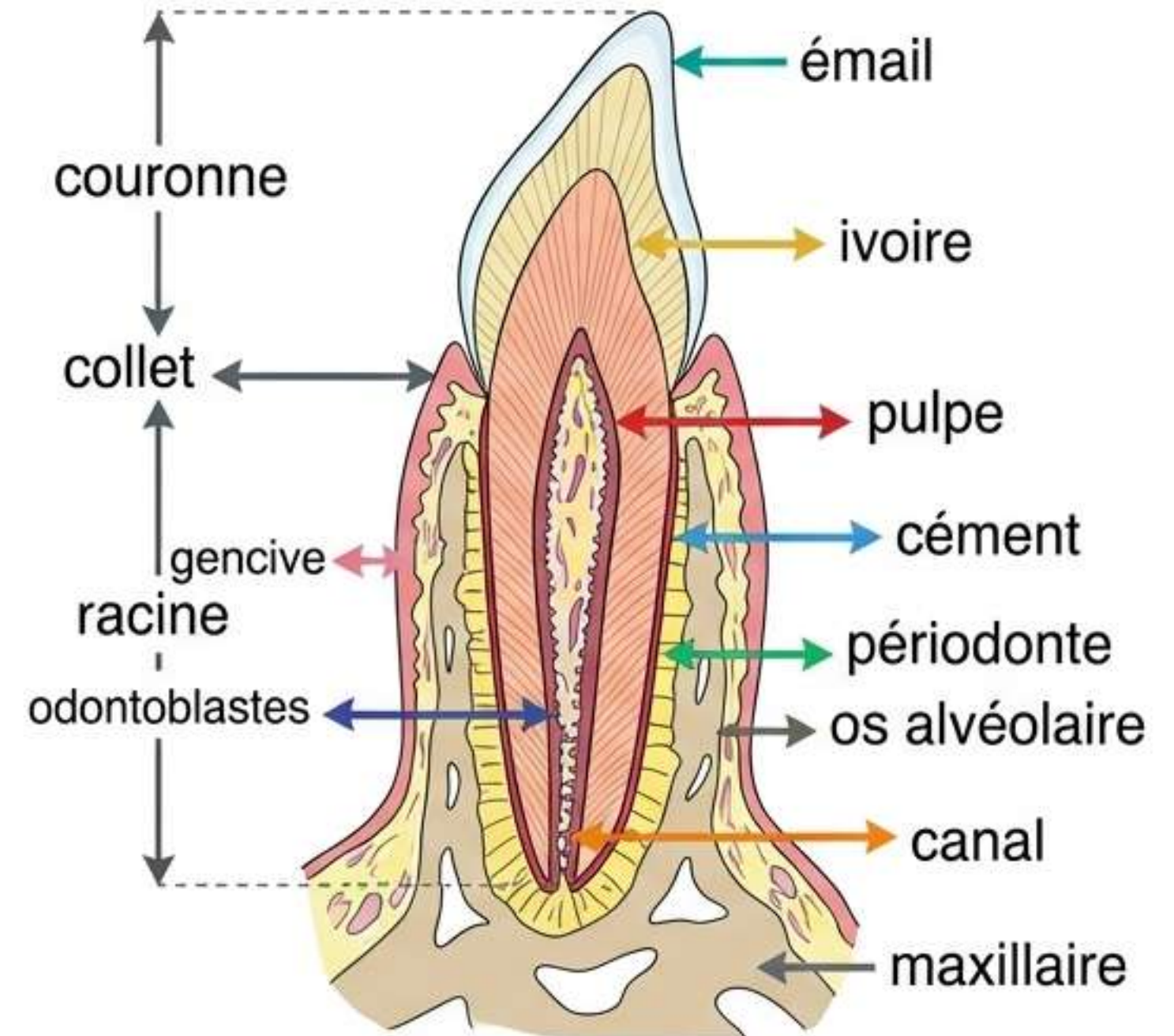
- Tumeurs siégeant exclusivement dans les mâchoires. Structure s'apparente à un stade de l'odontogénèse.

Rappel Histologique :

- *Ébauche Épithéliale (Organe de l'émail)* → Préaméloblastes → Améloblastes → Émail.
- *Portion Conjonctive (Papille)* → Pulpe, Dentine (Odontoblastes), Cément.

Principes de Classification :

1. Épithéliales pures.
2. Mixtes (Épithéliales + Conjonctives).
3. Ectomésenchymateuses pures.



Classification OMS : Tumeurs Odontogènes Bénignes (Groupes 1 & 2)

A) Épithéliales Pures (Groupe 1)

1. Améloblastomes. [Predicted – Reason: High frequency]
2. T. odontogènes épidermoïdes.
3. T. épithéliales odontogènes calcifiées.
4. T. odontogènes à cellules claires.

B) Mixtes (Épithéliales + Conjonctives) (Groupe 2)

*Avec ou sans tissu dentaire dur

1. Fibrome améloblastique.
2. Fibro-dentinome améloblastique.
3. Fibro-odontome améloblastique.
4. Odonto-améloblastomes.
5. Kyste odontogène calcifié.
6. T. odontogène adénomatoïde.
7. Odontomes complexes.

Classification OMS : Groupe 3, Malignes & Pseudotumeurs

C) Ectomésenchymateuses Pures (Groupe 3)

- 1. Fibrome odontogène.
- 2. Myxome odontogène.
- 3. Cémentoblastome.

V) Tumeurs Malignes

Carcinomes : Améloblastome malin, Carcinome intra-osseux, T. à cellules claires.

Sarcomes : Fibrosarcome améloblastique, Odontosarcome, Carcinosarcome.

VI) Pseudotumeurs (Pièges d'Examen)

1. Kystes inflammatoires. [Ref: Q11, Q17]
2. Kystes dentigères.

Carte Mentale de Synthèse

